Vắc xin này có dưới 1 mmol natri (23 mg) mỗi liều, tức là cơ bản 'không có natri'.

Trẻ sơ sinh và trẻ em từ 6 tuần đến 5 tuổi

Trong các nghiên cứu lâm sàng, Prevenar 13 kích thích sinh đáp ứng miễn dịch với tất cả 13 týp huyết thanh có trong vắc xin. Đáp ứng miễn dịch cho týp huyết thanh 3 sau liều nhắc lại không tăng cao hơn nồng độ quan sát thấy sau liệu trình tiêm chủng cơ bản cho trẻ sơ sinh; chưa biết sự liên quan lâm sàng của quan sát này với sự kích thích sinh khả năng nhớ miễn dịch cho týp huyết thanh 3 (xem mục 5.1).

Tỷ lệ đáp ứng kháng thể chức năng (hiệu giá OPA (hoạt tính thực bào) ≥1:8) với týp huyết thanh 1, 3 và 5 cao. Tuy nhiên, hiệu giá trung bình nhân OPA của các týp này thấp hơn hiệu giá của từng týp huyết thanh vắc xin còn lại; chưa biết sự liên quan lâm sàng của quan sát này đối với công hiệu bảo vệ (xem mục 5.1).

Một số dữ liệu đã cho thấy rằng vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn (liệu trình chính gồm 3 liều) tạo đáp ứng miễn dịch có thể chấp nhận được ở trẻ sơ sinh có bệnh tế bào hình lưỡi liềm với tính chất an toàn tương tự như dữ liệu quan sát thấy ở những nhóm không có nguy cơ cao (xem mục 5.1).

Trẻ em dưới 2 tuổi nên được áp dụng liệu trình tiêm chủng Prevenar 13 thích hợp với độ tuổi (xem mục 4.2). Việc sử dụng vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn không thay thế việc sử dụng PPSV23 (pneumococcal polysaccharide vaccine – vắc xin polysaccharid chứa 23 týp phế cầu khuẩn) ở trẻ em từ 24 tháng tuổi trở lên bị bệnh tế bào hình lưỡi liềm, không có lách, nhiễm HIV, bệnh mạn tính hoặc những trẻ bị suy giảm miễn dịch dẫn đến nguy cơ cao hơn mắc bệnh xâm lấn do *Streptococcus pneumoniae*. Bất cứ khi nào được khuyến cáo, trẻ em có nguy cơ ≥24 tháng tuổi và đã dùng Prevenar 13 nên được dùng vắc xin polysaccharid phế cầu khuẩn 23 dòng. Khoảng cách giữa vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn 13 giá (Prevenar 13) và vắc xin polysaccharid 23 dòng phế cầu khuẩn không được ít hơn 8 tuần. Không có dữ liệu cho thấy việc cho dùng vắc xin polysaccharid 23 dòng phế cầu khuẩn ở trẻ em chưa tiêm chủng hoặc ở trẻ em đã tiêm chủng Prevenar 13 có thể dẫn đến giảm đáp ứng với các liều Prevenar 13 sau đó.

Nên xem xét nguy cơ có thể bị ngừng thở và nhu cầu theo dõi hô hấp trong 48-72 tiếng khi áp dụng liệu trình tiêm chủng chính cho trẻ sơ sinh rất thiếu tháng (ra đời ≤28 tuần mang thai), và đặc biệt là cho những trẻ có tiền sử hô hấp chưa phát triển. Ở nhóm trẻ sơ sinh này lợi ích chủng ngừa là cao, do đó không nên bỏ qua hoặc trì hoãn tiêm chủng.

Với các týp huyết thanh có trong vắc xin, khả năng bảo vệ ngừa viêm tai giữa được dự kiến sẽ thấp hơn khả năng bảo vệ ngừa bệnh xâm lấn. Vì viêm tai giữa là do nhiều vi khuẩn khác ngoài các týp huyết thanh phế cầu khuẩn có trong vắc xin, khả năng bảo vệ ngừa tất cả các tình trạng viêm tai giữa dự kiến sẽ thấp (xem mục 5.1).

Khi Prevenar 13 được dùng đồng thời với Infanrix hexa (DTPa-HBV-IPV/Hib), mức độ phản ứng sốt tương tự như phản ứng sốt được quan sát thấy khi dùng vắc xin cộng hợp 7 týp phế cầu khuẩn đồng thời với Infanrix hexa (xem mục 4.8).

Quan sát thấy tăng tỷ lệ báo cáo co giật (kèm sốt hoặc không kèm sốt) và cơn giảm phản ứng - giảm trương lực (HHE) khi cho dùng đồng thời Prevenar 13 và Infanrix hexa (xem mục 4.8).